

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096970-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDMILSON PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS. LAUDO MÉDICO ATESTA A EXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam, em no máximo em 10 (dez) dias, o exame de Monitoramento pelo Sistema Holter 24 Horas, a partir da intimação. Na impossibilidade, seja a autora encaminhada para clínica ou hospital privado, conveniadas ao SUS, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica Privados e o SUS. O descumprimento da presente decisão, no prazo acima fixado, ensejará a aplicação de multa única no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie.. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5096970-65.2024.4.02.5101

510015088360 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5096970-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDMILSON PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pelo autor, em face de despacho, evento 3 dos autos originários, que indeferiu exame de Monitoramento pelo Sistema Holter 24 Horas em até 72 (setenta e duas) horas, diagnosticado com hipertensão secundária (CID10:I15), conforme documento médico anexo aos autos (Evento 1, Anexo 2, pág. 8).

Eis o teor do despacho:

EDMILSON PINTO DE OLIVEIRA propõe ação em face da UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO postulando, em tutela de urgência, a realização de exame de monitoramento pelo Sistema Holter - 24 Horas, em razão do diagnóstico de hipertensão secundária (CID10:I15). Ao final, requer a confirmação da medida. Requer gratuidade de justiça.

Como causa de pedir, afirma que está em acompanhamento médico junto ao CMS Adelino Simões - Nova Sepetiba e possui o diagnóstico de hipertensão secundária (CID10:I15). Sustenta que, em razão do seu quadro clínico, foi prescrita a realização de exame de monitoramento pelo sistema Holter - 24 Horas. Ressalta que a solicitação para a realização do exame foi inserida em 22/08/2024 no sistema de regulação, com classificação de risco amarelo (situações clínicas que necessitam de agendamento prioritário), e seu status permanece pendente. Alega, ainda, que houve uma primeira solicitação para esse procedimento em 12/06/2022, não sendo razoável essa longa espera.

Inicial e documentos nos ev. 1 e 3, incluindo os dados da solicitação do procedimento em 22/08/2024 (ev. 1, anexo 2, fls. 8/9 e ev. 3).

Certidão no ev. 4 atestando que o paciente está inserido no SISREG com classificação de risco amarelo e segue aguardando vaga.

Decisão no ev. 5 deferindo o pedido de gratuidade de justiça e determinando a oitiva do NAT.

Parecer do NAT no ev. 8 apontando que não foi juntado aos autos laudo médico atualizado que justifique o pleito, bem como a existência de solicitação em 24/08/2024 para realização de monitoramento cardíaco - Holter 24 horas, ainda pendente.

Decido.

De acordo com os documentos juntados aos autos, há solicitação no SISREG em 24/08/2024 para realização de monitoramento cardíaco pelo sistema Holter 24 horas.

Considerando que o autor já foi inserido no SISREG e se encontra em fila aguardando vaga para realização do procedimento e, ainda, que não há nenhum documento que permita concluir ser o seu quadro clínico mais grave que o dos demais pacientes, usuários do SUS com iguais direitos e que estão à sua frente na fila, **INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.**

Ao autor para emendar a inicial em 15 (quinze) dias, juntando laudo médico atualizado firmado em unidade do SUS, com a indicação do seu quadro clínico e da conduta terapêutica a ser seguida, para embasamento de sua pretensão.

Após a apresentação do laudo médico, cite-se nos termos do art. 9º da L. 10.259/2001, devendo os réus juntarem, no prazo da defesa, toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 11 da mesma lei, sob pena de aplicação do artigo 400 do CPC, bem como informarem sobre a possibilidade de conciliação e, em caso positivo, apresentarem proposta de acordo, no prazo de 30 dias.

Não havendo cumprimento, voltem conclusos para extinção. (rc)

O autor, de 49 anos, em acompanhamento médico junto ao CMS Adelino Simões - Nova Sepetiba, possui o diagnóstico de hipertensão secundária (CID10:I15). Devido ao seu quadro clínico, foi prescrita a necessidade de realização do exame de monitoramento pelo sistema Holter - 24 Horas. Devido a demora no atendimento, o autor buscou auxílio da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, a qual, em consulta ao SISREG - Sistema de Regulação, verificou que, a solicitação para a realização do exame pleiteado foi inserida em 22/08/2024, com classificação de risco Amarelo (utilizada para situações clínicas que necessitam agendamento prioritário) estando com a situação atual: pendente. **No entanto destacou-se que o autor se encontra aguardando pelo procedimento desde o dia 12/06/2022 quando ocorreu a primeira solicitação, que restou cancelada aos 07/05/2023 por ausência de resposta do CMS.**

Tutela deferida em decisão desta relatora no evento 3

Sem contrarrazões.

Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde - SUS, "sic":

"Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo." (grifo nosso)"

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(...)

A ênfase na municipalização passa então a ser também princípio do SUS, inserido no inciso IX, artigo 7º, da Lei 8.080/90. Cabe assim precipuamente aos Municípios a responsabilidade pela execução e pela prestação direta dos serviços de saúde (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei n.º 8.080/90). Isso se compatibiliza com o sistema com o estabelecido também pela Constituição no artigo 30, VII: "*Compete aos Municípios (...) prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.*"

Destarte, fica evidente que as responsabilidades quanto à execução das ações finalísticas de prestação de serviços de saúde, dividem-se entre a União, os Estados e os Municípios, cada um dentro de suas respectivas esferas de atribuição, devendo-se ressaltar aqui, que à União compete basicamente a formulação de políticas nacionais, financiamento do Sistema, com o repasse de verbas próprias a Estados e Municípios, sendo que a estes últimos ficaria a principal atribuição de prestar o atendimento ao cidadão, especialmente no campo do fornecimento de medicamentos.

Vejamos agora questões específicas que se apresentam regularmente nesta Justiça Federal.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

As atribuições relativas à assistência farmacêutica no campo da saúde pública, englobam as *atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização - compreendidas a prescrição e a dispensação - de medicamentos* (artigos 16, X; 17, VIII; e 18, V, da Lei n. 8.080/1990 e item 3.3 da Portaria MS n. 3.916, de 30 de outubro de 1998 - Política Nacional de Medicamentos). O Decreto nº 7.508/11 recentemente deu nova regulamentação à Lei 8.080/80, não alterando a linha da descentralização.

Em toda hierarquização e descentralização quanto ao fornecimento direto de medicamentos e demais insumos respectivos, fica claro que: (i) cabem ao gestor municipal as responsabilidades para definição dos medicamentos essenciais e para o seu abastecimento. Ou seja, os medicamentos fornecidos pelo município são aqueles considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população; (ii) compete aos Estados federados a dispensação de medicamentos de ordem excepcional, ou seja, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja compra e disponibilização atende a casos específicos; (iii) por fim, quanto à União Federal, é conferida pela Política Nacional de Medicamentos a responsabilidade em adquirir e distribuir produtos em situações especiais considerando três pressupostos básicos, de ordem epidemiológica, a saber: a) doenças que configuram problemas de saúde pública, que atingem ou põem em risco a coletividade, e cuja estratégia de controle concentra-se no tratamento de seus portadores; b) doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados; c) doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos não disponíveis no mercado.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a competência da União no fornecimento de medicamentos, conforme farta regulamentação, se refere aos: a) medicamentos de interesse em saúde pública: aqueles utilizados no controle de doenças que, em determinada comunidade, têm magnitude, transcendência ou vulnerabilidade relevante e cuja estratégia básica de combate é o tratamento dos doentes; e b) medicamentos de uso contínuo: são aqueles empregados

no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente, sendo que em ambos os casos, só serão fornecidos pela União aqueles que se encaixarem no perfil estratégico concernente à definição de sua esfera de responsabilidade.

Com base nessa divisão de responsabilidades, delimita-se a competência da Justiça Federal e consequentemente dos Juizados Especiais Federais para apreciar as ações que objetivam o fornecimento de medicamentos, atendo-se somente àquelas em que a dispensação de medicamentos caiba à União Federal.

Na mesma linha da argumentação acima, segue parte da jurisprudência do STJ e também a jurisprudência pacífica do TRF da 2ª Região, conforme, com grifos nossos:

“SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DIRETA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. I - A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegitimidade da União para figurar em ação para fornecimento gratuito de medicamentos. II - A competência da União está adstrita à gestão federal do SUS, repassando os recursos financeiros, cabendo então aos Municípios e, supletivamente, aos Estados, a aquisição e a adequada dispensação de medicamentos. Precedente: (AgRg no REsp nº 888.975/RS, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22.10.2007). III - Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no Ag 879.975/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Dje 14/04/2008)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A sentença, também condicionada a reexame necessário, ratificando a decisão antecipatória, condenou somente a União a fornecer ao autor, portador de esquizofrenia psicótica, os medicamentos Losartana Potássica 100mg/dia; Pimozida 04 mg/dia; Flurazepan 30 mg/dia, e Dicloridrato de Manidipin, disponibilizando quantidade suficiente para o tratamento no período de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com a necessidade diária prescrita nos laudos médicos..., nas quantidades mensais especificadas com base nos receituários..., devendo o Autor apresentar, a cada 06 (seis) meses, receituário atualizado, comprovando a necessidade de uso continuado dos referidos medicamentos. 2. A União Federal, em regra, no âmbito do SUS, não tem atribuição de distribuir diretamente medicamentos, do que decorre a sua ilegitimidade passiva para responder ações movidas para obtê-los. Inteligência da Lei nº 8.080/90. Precedentes da Turma. 3. A remessa dos autos à Justiça Estadual, melhor ajustada à sistemática do SUS, tem o efeito prático de aproximar os pacientes necessitados de assistência médico-farmacêutica dos organismos locais responsáveis, assim otimizando a efetividade das prestações demandadas. 4. Na hipótese, a parte autora, portadora de esquizofrenia psicótica, necessita de remédios não integrantes da lista de medicamentos excepcionalmente fornecidos pela União Federal, e dos autos não consta laudo médico categórico afirmativo da essencialidade dos medicamentos em causa, destacando-os como únicos e insubstituíveis para restabelecer a saúde do paciente, e situando-o, nessa medida, em quadro excepcional para justificar tratamento diferenciado, de sorte que se impõe a remessa do feito ao Estado. 5. Apelação da União Federal e Remessa Necessária providas. Apelação da parte autora e agravo retido prejudicados.”

(TRF2, APELRE 200951010132455, Desembargadora Federal NIZETE LOBATO CARMO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 22/01/2013.)

“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO PÓLO PASSIVO. 1. Agravos internos contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a exclusão da União do pólo passivo da demanda na qual se pede a entrega de medicamentos, com a remessa dos autos ao Juízo estadual competente. 2. A asseveração de solidariedade apenas significa que os entes federativos dos três níveis têm o dever de compor o sistema de saúde pública, na forma delineada pela Constituição Federal e especificada pela legislação infraconstitucional. Assim, ela é insuficiente para fazer com que se possa litigar ou não contra a União Federal, em casos nos quais não existe, na distribuição interna das competências, dever da União de comprar ou fornecer o remédio específico. 3. Agravos internos não providos.”
(TRF2, AG 201202010183666, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 17/12/2012.)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA DO ESTADO.

Em regra, não é pertinente a inserção da UNIÃO FEDERAL no pólo passivo de pleito em que se objetiva obter remédios. A atuação da União Federal, no âmbito do problema relativo a medicamentos, não é a de comprá-los e de distribuí-los, diretamente. O Sistema Único de Saúde objetiva coordenar os recursos e práticas

ligadas à saúde pública, de modo a dividir atribuições e obter eficiência. Não cabe à União a compra e a entrega direta de medicamentos, salvo os casos especiais previstos na divisão de atribuições. Assim, exclui-se da lide a União Federal e, com fulcro no artigo 113 do CPC, pronuncia-se a nulidade da sentença, determinada a remessa dos autos à Justiça do Estado, para que lá tudo seja apreciado. Remessa (conhecida de ofício) e apelação da UNIÃO FEDERAL providas. Prejudicado o apelo do Estado do Rio de Janeiro.(TRF2 - AG 201202010107937, Rel. p/acórdão GUILHERME COUTO, E-DJF2R - Data::26/09/2012.)

“PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conquanto a apreciação do agravo retido interposto pela União não tenha sido requerida em sua apelação (art. 523, § 1º, do CPC), o recurso poderia ser conhecido por força da remessa necessária. Todavia, não o será porquanto se insurge contra o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e porque a ilegitimidade passiva suscitada é reiterada nas razões de apelação. 2. A aquisição e distribuição dos medicamentos para combater a doença que acomete a autora (glaucoma) inserem-se entre as atribuições do Estado e do Município (art. 9º, §1º, inciso II, da Portaria nº 288/ SAS, de 19 de maio de 2008). Desprezar a repartição de atribuições, prevista na Lei nº 8.080/90 (artigos 16 a 19) e demais normas que regulamentam o funcionamento do SUS, torna o sistema ineficiente e dispendioso, notadamente em vista de condenações solidárias dos entes ao fornecimento dos mais variados medicamentos. A União não tem a incumbência de adquiri-los e distribuí-los, pois os medicamentos pleiteados não estão listados na Portaria nº 2.981/2009. Reconhecida a ilegitimidade da União e, portanto, a incompetência da Justiça Federal, deve ser declarada a nulidade da sentença e encaminhado o processo à Justiça Estadual (art. 113, § 2º, do CPC). 3. Agravo retido da União não conhecido e remessa e apelação da União providas. Prejudicados os recursos dos demais réus.” (grifou-se e destacou-se).(TRF2, AC 200851010252432, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 08/03/2013)

Conforme Parecer do NATJUS no evento 8 dos autos originários, consta que "Adicionalmente, em consulta à plataforma da Secretaria Municipal de Saúde - Transparência do SISREG Ambulatorial (ANEXO I), foi identificada solicitação de Monitoramento Cardíaco - Holter 24 hs, solicitado em 24/08/2024, pelo Centro Municipal de Saúde de Adelino Simoes Nova Sepetiba, diagnóstico inicial: Hipertensão Essencial (Primária), classificação de risco Amarelo - urgência, situação: Pendente, com a seguinte justificativa: paciente em câmara de litígios, sem vagas disponíveis no momento.

Ocorre que o autor comprovou nos autos que houve, em 2023, cancelamento de seu agendamento realizado em 2022, conforme documento abaixo:

DEMANDA/LITÍGIO - CRLS Nº 20241014000003 –
NOME EDMILSON PINTO DE OLIVEIRA

Prezados,

O presente parecer, elaborado pela equipe técnica da CRLS, objetiva informar a Defensoria Pública e Unidade (s) de Saúde assistentes acerca do encaminhamento do(s) produto(s) pleiteado(s) pelo(a) assistido(a) EDMILSON PINTO DE OLIVEIRA 49 anos, CNS: 704601122293528, domicílio declarado à RUA CINQUENTA E SEIS 1 NOVA SEPETIBA Telefone: (21)9813-18028, Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência: CMS ADELINO SIMOES NOVA SEPETIBA AP 53.

PRODUTO(S) PLEITEADO(S): HOLTER 24 HORAS

DOCUMENTO(S) ANALISADO(S): Tela SISREG

DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:

Cumpre-se informar que atualmente as vagas para o procedimento pleiteado são gerenciadas através do Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

Em consulta ao SISREG foi identificado:

- Solicitação # 554184810 para MONITORAMENTO CARDIACO - HOLTER 24 HS inserida em 22/08/2024 por CMS ADELINO SIMOES NOVA SEPETIBA AP53, classificação de risco Amarelo lo Situação atual: Pendente.

Cabe às equipes assistentes da Atenção Primária de Saúde (APS), conduzir as demandas de saúde identificadas de acordo com os fluxos e linhas de cuidado preconizadas pela SMS/RIO.

Cumpre-se informar sobre os prazos de regulação ambulatorial ajustados à classificação de risco por cores, estabelecidos pela SMS/RIO no Protocolo do Regulador:

_ AMARELO: são situações clínicas que necessitam um agendamento prioritário, podendo aguardar até 90 dias.

Destaca-se que o Assistido encontra-se aguardando pelo SISREG desde o dia 12/06/2022 para MONITORAMENTO CARDIACO - HOLTER 24 h e com a situação cancelado em 07/05/2023 por está sem resposta do CMS.

Em acordo firmado entre a CRLS e a Complexo Regulador (CR), ficou estabelecido que em casos classificados como VERMELHO, AMARELO OU VERDE e com o prazo de regulação rompido na data da análise; o CR se posicionará sobre a solicitação em prazo de 7

Diante desta informação, analisada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada indeferida pelo Juízo *a quo*, visto que o autor fora excluído da fila de atendimento do SUS, sem qualquer justificativa ou nova previsão de tratamento, não podendo esperar ad eternum a providência do Estado do Rio de Janeiro para efetuar sua nova inclusão no sistema.

Vale ressaltar que o período que o autor restou aguardando o tratamento é por demais longo, por mais de 2 anos, tendo sido o mesmo cancelado sem qualquer justificativa e nem apresentada alternativa de tratamento.

Constato que há risco de dano irreparável em prejuízo da recorrente, pois restou incontroverso o estado grave de saúde que se encontra o autor, bem como a falha da prestação do servido do Estado do Rio de Janeiro e sua inércia em fornecer atendimento ao autor.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso, **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS, forneçam, em no máximo em 10 (dez) dias, o exame de Monitoramento pelo Sistema Holter 24 Horas, a partir da intimação. Na impossibilidade, seja a autora encaminhada para clínica ou hospital privado, conveniadas ao SUS, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica

Privados e o SUS. O descumprimento da presente decisão, no prazo acima fixado, ensejará a aplicação de multa única no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, não afastada a adoção das demais medidas coercitivas aplicáveis à espécie.. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.